VISIONSEEK

VisionSeek · GULF MEDICINE IMPORTS · v1.1

أمننا الدوائي في الخليج

من أين يأتي دواؤنا الأساسي؟

مبني على بحث أجرته VisionSeek

DOI: 10.5281/zenodo.23657727

أكتوبر 2026

إعداد: د. أحمد عبدالعليم، VisionSeek

كيف تقرأ هذا التقرير: [مؤكد بمصدر] رقم أو حقيقة من بحث VisionSeek الأصلي، وموضع كل رقم في الملحق «من أين جاءت الأرقام». [استنتاج] قراءتنا التحليلية لما تعنيه الأرقام لصانع القرار.

1. الملخص التنفيذي

خلاصات قابلة للاقتباس

1. **«على الورق، الخليج يشتري دواءه من العالم كله.»** تأتي واردات الأدوية الجاهزة لكل دولة من 49 إلى 101 دولة، ومؤشر التركّز بين 588 و2,277؛ أي سوق متنوعة في مجملها [مؤكد بمصدر].
2. **«الإنسولين معلّق بدولة مورّدة واحدة.»** مؤشر تركّز الإنسولين الجاهز بين 5,663 و9,407، وألمانيا وحدها تورّد 73–97% منه في خمس من الدول الست [مؤكد بمصدر].
3. **«الواردات المسجلة من الإنسولين الخام زهيدة.»** بضع مئات إلى بضعة آلاف من الدولارات لكل دولة. لكن الدول المصدّرة سجّلت 2.21 مليون $ إنسولين خام شُحن إلى الإمارات في 2023، فجزء من المشكلة في طريقة التسجيل نفسها [مؤكد بمصدر].
4. **«الخطر قد ينتقل إلى أعلى السلسلة (نتيجة أولية).»** في السعودية والإمارات وعُمان، حيث تُستورد المواد الفعالة للمضادات الحيوية بكميات معتبرة، كانت هذه المواد أشد تركّزًا من الأدوية الجاهزة في خمس من ست مقارنات، ومصدرها آسيوي في الغالب [مؤكد بمصدر].
5. **«الإمارات محطة توزيع الخليج.»** أعادت تصدير نحو ربع وارداتها من الأدوية الجاهزة، ونحو 92% من الإنسولين، في 2023 [مؤكد بمصدر].
6. **«تركّز عُمان أثر المحطة لا المنشأ.»** يهبط مؤشرها من 1,940 إلى 823 إذا استبعدنا ما يمرّ عبر جيرانها الخليجيين؛ لكنه في الإنسولين يرتفع من 6,955 إلى 8,854 [مؤكد بمصدر].
7. **«خلف الهند تقف الصين.»** بحسب ما يعلنه المصدّرون، الصين أكبر مورّد للمواد الفعالة للمضادات الحيوية إلى الإمارات، وألمانيا تورّد 91% من إنسولينها في 2024 [مؤكد بمصدر].

الرسالة لصانع القرار: نسبة «السوق المغطاة محليًا» لا تكفي. السؤال الحاسم: أي مرحلة من صناعة الدواء نوطّنها، وهل تتحرك واردات المواد الخام صعودًا مع التوطين؟ [استنتاج]

2. الصورة الكبيرة: سوق متنوعة في الظاهر

الدولة	السنة	قيمة واردات الأدوية الجاهزة	مؤشر التركّز	المورّد الأكبر
السعودية	2024	6.30 مليار $	762	ألمانيا
الإمارات	2023	4.70 مليار $	848	الولايات المتحدة
الكويت	2024	1.67 مليار $	1,083	الولايات المتحدة
قطر	2024	0.83 مليار $	1,062	الولايات المتحدة
عُمان	2024	0.52 مليار $	1,940	الإمارات
البحرين	2024	0.39 مليار $	735	الولايات المتحدة

[مؤكد بمصدر]

- خمس دول تشتري من 70–101 دولة، والمورّد الأكبر لا يتجاوز 15–24%، وأكبر ثلاثة معًا 36–52% [مؤكد بمصدر].
- **لكن الاتجاه نحو التركّز:** الكويت من 824 في 2019 إلى 1,083 في 2024، وحصة أكبر ثلاثة موردين من 41% إلى 52%؛ وقطر من 832 إلى 1,062، وحصة الولايات المتحدة من 18% إلى 24% [مؤكد بمصدر].
- **عُمان تشتري عبر الإمارات:** الإمارات مورّدها الأكبر في كل السنوات عدا 2021 بحصة 31–39% [مؤكد بمصدر].
- **أين تختفي التفاصيل:** معظم أدوية القلب والسكري الفموية مدفونة في بند «أدوية أخرى»، وهو الأكبر في كل دولة: 4.63 مليار $ للسعودية (2024)، 3.56 مليار $ للإمارات (2023)، 1.28 مليار $ للكويت (2024)، بمؤشر تركّز 753–1,077 في خمس دول. هذا البند يبدو متنوعًا، ولا يكشف إن كان دواء بعينه معلّقًا بدولة مورّدة واحدة [مؤكد بمصدر].

3. الإنسولين: أوضح نقطة ضعف

الدولة	السنة	قيمة واردات الإنسولين الجاهز	مؤشر التركّز	المورّد الأكبر وحصته
السعودية	2024	209.4 مليون $	5,663	ألمانيا 73%
الإمارات	2023	72.4 مليون $	5,725	ألمانيا 74.1%
الكويت	2024	25.4 مليون $	8,165	ألمانيا 89.8%
عُمان	2024	12.3 مليون $	6,955	الإمارات 81.8%
قطر	2024	7.3 مليون $	8,314	ألمانيا 91%
البحرين	2024	6.3 مليون $	9,407	ألمانيا 97%

[مؤكد بمصدر]

- **الإمارات تمرّر ولا تستهلك:** استوردت 72.4 مليون $ في 2023 وأعادت تصدير 66.9 مليون $ (نحو 92%)، فبقي 5.5 مليون $ فقط داخلها [مؤكد بمصدر].

- **الإنسولين الخام شبه غائب في السجلات:** البحرين 358 $ (2023)، الكويت 887 $ (2024)، السعودية 1,765 $ (2023)، الإمارات 3,496 $ (2023)، عُمان 5,808 $ (2022)؛ ولا سجل لقطر [مؤكد بمصدر].
- **لكن السجلات ناقصة:** المصدّرون سجّلوا 2.21 مليون $ إنسولين خام إلى الإمارات في 2023 (الهند 100%)، مقابل 3,496 $ في سجل الإمارات [مؤكد بمصدر].
- **ماذا يعني ذلك:** إنسولين الخليج يأتي جاهزًا من دولة موّردة واحدة في الغالب. وتوطينه بالتعبئة المحلية يتطلب أن تنمو قناة استيراد الخام أيضًا؛ وارتفاع الواردات المسجلة من الإنسولين الخام سيكون إشارة مبكرة لبدء التعبئة محليًا [مؤكد بمصدر].

4. المضادات الحيوية: الخطر يصعد إلى المادة الخام

- **البنسلين الجاهز** متوسط التركّز: 1,525 في السعودية (2024) و2,041–3,291 في بقية الدول، وموّردوه أوروبيون في الغالب [مؤكد بمصدر].
- **مادة البنسلين الخام** أشد تركّزًا: السعودية 12.2 مليون $ (2024) بمؤشر 2,935 وسنغافورة 41%؛ الإمارات 6.7 مليون $ (2023) بمؤشر 8,542 والهند 92%؛ عُمان 1.4 مليون $ (2024) بمؤشر 8,547 والإمارات 92% [مؤكد بمصدر].
- **مضادات حيوية أخرى (خام):** الصين في الصدارة للسعودية (29%؛ مؤشر 2,170)، والهند للكويت وعُمان والإمارات [مؤكد بمصدر].
- **التتراسيكلين الخام:** السعودية 5.27 مليون $ في 2024، 93% منها من الصين (مؤشر 8,731) [مؤكد بمصدر].
- **مشتقات الإريثرومايسين الخام:** الهند في الصدارة للسعودية (68%) والإمارات (84%) وعُمان (54%) [مؤكد بمصدر].
- **ما يقوله المصدّرون عن الإمارات:** سجلات الإمارات تُظهر الهند موّردًا لـ92% من مادة البنسلين، بينما تُظهر سجلات المصدّرين الصين في الصدارة (53–56%؛ مؤشر نحو 4,600–4,800). وفي الحالتين: المادة الخام آسيوية وأشد تركّزًا من الدواء الجاهز [مؤكد بمصدر].
- **قراءتنا:** التوطين بالتعبئة والتركيب لا يلغي الخطر؛ قد ينقله من موّرد الدواء الأوروبي إلى عدد قليل من موّردي المواد الخام الآسيويين [مؤكد بمصدر] [استنتاج].

5. أين يقف الخليج من امتلاك صناعة الدواء

تحديد موقع كل دولة على «سلّم الامتلاك» يحتاج سجلات التسجيل الدوائي، وهو موضوع المرحلة الثانية من هذا البحث. ما تقوله أرقام التجارة وحدها: غياب واردات معتبرة من المواد الخام يشير إلى أن الصناعة المحلية، إن وُجدت، في المراحل المتأخرة كالتعبئة والتغليف، والسعودية استثناء جزئي باستيرادها مواد خام للمضادات الحيوية بقيم غير هامشية [مؤكد بمصدر].

6. ماذا يعني هذا لصنّاع القرار في دول الخليج

1. **قيسوا المرحلة لا الحصة.** هدف «نسبة السوق المغطاة محليًا» لا يقول أي مرحلة توطّنت. مؤشر يتابع واردات الدواء الجاهز وموادّه الخام معًا يكشف إن كان التوطين يتحرك صعودًا [مؤكد بمصدر].
2. **اجعلوا الإنسولين أولوية أمن دوائي.** خمس دول معلّقة بدولة موّردة واحدة، والخام شبه غائب؛ التعبئة المحلية وحدها لا تحل المشكلة دون قناة استيراد للخام [مؤكد بمصدر].
3. **لا تفترضوا أن التوطين يلغي الخطر.** قد ينقله إلى عدد قليل من موّردي المواد الخام الآسيويين [مؤكد بمصدر].

4. **خططوا للمحطة كنقطة فشل مشتركة.** تعطّل محطة الإمارات يصيب عدة دول خليجية معًا، ومؤشرات المنشأ لا تلتقط ذلك [مؤكد بمصدر]. خطط الطوارئ الدوائية تحتاج قراءة على مستوى مجلس التعاون لا الدولة وحدها [استنتاج].
5. **وحّدوا تعريف «الإنتاج المحلي».** الأرقام السعودية المنشورة تتراوح بين نحو الخُمس وما يزيد قليلًا على الثلث بحسب طريقة الحساب؛ وأرقام التجارة تقدّم مرجعًا مستقلًا عن هذا الخلاف [مؤكد بمصدر].

7. أسئلة مفتوحة

1. أي مرحلة من الصناعة يمارسها كل بلد فعلًا في كل دواء؟ (المرحلة الثانية: من سجلات التسجيل الدوائي.)
2. كم تعتمد السعودية على الاستيراد بالقيمة لا بالحصة؟ يتطلب رقمًا رسميًا لقيمة الإنتاج المحلي.
3. ماذا يختبئ خلف محطة الإمارات، ولا سيما ما تشتريه عُمان؟ يتطلب سجلات المصدّرين للدول الخمس الأخرى.
4. ما تفسير القيود الغريبة: منشأ «ماكاو» لمادة التتراسيكلين إلى الإمارات، وإعادة تصدير تفوق الاستيراد في بعض المواد الخام؟
5. كيف تبدو الصورة على مستوى الشركات المالكة للتسجيل، لا الدول؟

8. كيف بُني التقرير

- **المصدر:** بحث أجرته VisionSeek على 24 دواءً مؤشرًا من قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية 2025، ببيانات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير المعلنة من الدول الست في UN Comtrade للفترة 2019–2024، سُحبت في 25 أكتوبر 2026 عبر الواجهة العامة (حد 500 صف). النسخة الحالية أولية ولم تمر بتحكيم علمي بعد.
- **المقياس:** مؤشر هيرفندال-هيرشمان (HHI) لتركّز الموردين على مستوى الدولة: كلما ارتفع، زاد الاعتماد على عدد أقل من الدول المورّدة. إلى جانبه حصة المورّد الأكبر وأكبر ثلاثة وعدد المورّدين فوق 5%.
- **البنود الجمركية:** الدواء الجاهز HS 3004 (البنسلين 300410، الإنسولين 300431، أدوية أخرى 300490)؛ المواد الخام: الإنسولين 293712، البنسلين 294110، التتراسيكلين 294130، الإريثرومايسين 294150، مضادات أخرى 294190.
- **حدود يجب استحضارها:**
- بيانات الإمارات المعلنة تنتهي في 2023، وسجلات المصدّرين تغطي الإمارات وحدها (2023–2024)، وبين المصدرين فجوة كبيرة: 2.48 مقابل 4.70 مليار $ في 2023 لم تُسوَّ بعد.
- التركّز محسوب على مستوى الدولة المورّدة لا الشركة؛ والقيم اسمية بالدولار غير مخفّضة للتضخم؛ والمنشأ كما أُعلن، وإعادة الشحن قد تخطئه.
- قد يُسجَّل بعض الإنسولين ومدخلات أخرى ضمن الأدوية الجاهزة لا المواد الخام، فتبدو طبقة الخام أصغر من حقيقتها.
- معظم أدوية القلب والسكري الفموية في بنود جامعة لا تفصل الدواء، وبعض بنود المواد الخام مؤقتة؛ وبعض القيود الغريبة لم تُحل بعد.
- **من أين جاءت الأرقام:** الملخص → خلاصة البحث وأقسامه 3.2–3.8؛ §2 من هذا التقرير → البحث §3.2 والجدول 3 و§3.6 والجدول 6؛ §3 → §3.3 والجدولان 4a و4b و§3.8؛ §4 → §3.4 والجداول 5a–5d و§3.6 والجدول 8 و§3.8 والجدول 10؛ عُمان دون الخليجيين → §3.7 والجدول 9؛ §5–6 → §2.5 و§4؛ تعريفات الإنتاج المحلي → §1؛ الحدود → §5.
- **المراجعة:** مراجعة مستقلة من «باحث» قبل التسليم.

9. للاستشهاد

هذا التقرير: عبدالعليم، أحمد (2026). أمننا الدوائي في الخليج: من أين يأتي دواؤنا الأساسي؟. تقرير VisionSeek الاستراتيجي .v1.1 VisionSeek، إنتشون، كوريا الجنوبية.

البحث الأصلي: Abdelalim, A. (2026). *Who Owns the Gulf's Medicine? Finished-Product versus API Import Concentration for WHO Essential Medicines across the Six GCC States* (Preprint v1.0). VisionSeek, Incheon, South Korea. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23657727